GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA: DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO EN ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA Y SÍNDROME CORONARIO CRÓNICO

Ministerio de Salud y Protección Social / Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Código Documental: GPC-CARDIO-2024-V2

Área de Especialidad: Cardiología Clínica y Medicina Interna

---

1. Justificación y Propósito Clínico

La enfermedad arterial coronaria (EAC) representa la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel global. El objetivo de la presente guía es estandarizar los criterios diagnósticos, estratificación de riesgo cardiovascular y protocolos de abordaje clínico para pacientes que consultan con sospecha o confirmación de isquemia miocárdica en servicios de consulta externa y urgencias hospitalarias.

---

2. Semiología y Clasificación del Dolor Torácico (Chest Pain - CP)

El dolor torácico es el síntoma cardinal en la evaluación de cardiopatía isquémica. Clínicamente se categoriza en cuatro grupos estandarizados:

1. **Angina Típica (Tipo 1 / Confirmed Angina):**
- Cumple tres características simultáneas: (a) Dolor o malestar retroesternal u opresivo con irradiación a cuello, mandíbula, hombro o brazo izquierdo; (b) Desencadenado por esfuerzo físico, estrés emocional o frío; (c) Alivia en menos de 5 minutos con reposo o nitroglicerina sublingual.
- Implica una probabilidad pretest de enfermedad coronaria obstructiva superior al 85% en hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 60 años.

2. **Angina Atípica (Tipo 2 / Atypical Angina):**
- Cumple dos de las tres características de la angina típica.
- Frecuente en pacientes diabéticos, mujeres y adultos mayores. Se presenta comúnmente con equivalentes anginosos como disnea desproporcionada de esfuerzo, fatiga súbita o diaforesis.

3. **Dolor Torácico No Anginoso (Tipo 3 / Non-anginal Chest Pain):**
- Cumple únicamente una de las tres características descritas.
- Generalmente relacionado con causas osteomusculares, pleuríticas, gastroesofágicas o pericárdicas.

4. **Asintomático o Ausencia de Dolor (Tipo 4 / Asymptomatic):**
- Pacientes sin dolor torácico espontáneo pero con isquemia silente detectada por marcadores electrocardiográficos o estudios de extensión. Muy prevalente en neuropatía autonómica diabética.

---

3. Factores de Riesgo Cardiovascular Mayores y Parámetros Metabólicos

3.1. Presión Arterial en Reposo (Trestbps)

- **Tensión Normal:** Presión arterial sistólica (PAS) < 120 mmHg y diastólica (PAD) < 80 mmHg.
- **Prehipertensión:** PAS entre 120-139 mmHg o PAD entre 80-89 mmHg.
- **Hipertensión Estadio 1:** PAS 140-159 mmHg o PAD 90-99 mmHg.
- **Hipertensión Estadio 2 / Crisis Hipertensiva:** PAS ≥ 160 mmHg o PAD ≥ 100 mmHg.

Impacto clínico: Cada incremento de 20 mmHg en la PAS duplica el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE).

3.2. Colesterol Sérico Total (Chol) y Perfil Lipídico

- **Nivel Deseable:** < 200 mg/dL.
- **Límite Alto:** 200-239 mg/dL.

- **Hipercolesterolemia Severa:** ≥ 240 mg/dL.

Impacto clínico: El depósito lipídico en el endotelio vascular coronario promueve la formación de placas ateromatosas vulnerables a la rotura o erosión luminal.

3.3. Glucemia Basal en Ayunas (FBS)

- **Normal:** < 100 mg/dL.
- **Glucemia Alterada en Ayunas:** 100-125 mg/dL.
- **Criterio de Diabetes Mellitus:** FBS > 120-126 mg/dL (fbs = 1 en dataset clínico).

Impacto clínico: La diabetes mellitus es un equivalente de riesgo coronario; acelera la aterosclerosis difusa multivaso y la calcificación microvascular.

---

4. Electrocardiografía de Reposo (Resting ECG - Restecg)

La evaluación del ECG de 12 derivaciones en reposo clasifica al paciente en:

- **Categoría 0 (Normal):** Ritmo sinusal sin alteraciones de la conducción ni de la repolarización.
- **Categoría 1 (Anormalidades de la Onda ST-T):** Inversión simétrica de onda T (≥ 0.1 mV) o elevación/depresión del segmento ST > 0.05 mV. Altamente sugestivo de isquemia miocárdica activa subendocárdica o epicárdica.
- **Categoría 2 (Hipertrofia Ventricular Izquierda - HVI):** Cumplimiento de criterios de voltaje de Sokolow-Lyon (S en V1 + R en V5/V6 ≥ 35 mm) o de Cornell. Indica remodelado miocárdico secundario a sobrecarga de presión crónica por hipertensión arterial no controlada.

---

5. Algoritmo de Decisión Clínica y Priorización

1. Todo paciente con angina típica (Tipo 1) y factores de riesgo concurrentes (edad > 55 años, HTA estadio 1-2, hipercolesterolemia) debe ser clasificado como **Riesgo Cardiovascular Alto** y remitido a prueba de esfuerzo ergométrica o angiotomografía coronaria.
2. La presencia de alteraciones del segmento ST en el ECG basal asociada a disnea o dolor retroesternal requiere monitorización en sala de observación hospitalaria con dosificación seriada de troponinas de alta sensibilidad.